

«Кардіогенний шок»

Сценарій

Ви лікар з медицини невідкладних станів. В складі бригади екстреної медичної допомоги ви прибуваєте на виклик до чоловіка 62 років, який скаржиться на сильний загрудинний біль, що не купірується нітрогліцерином.

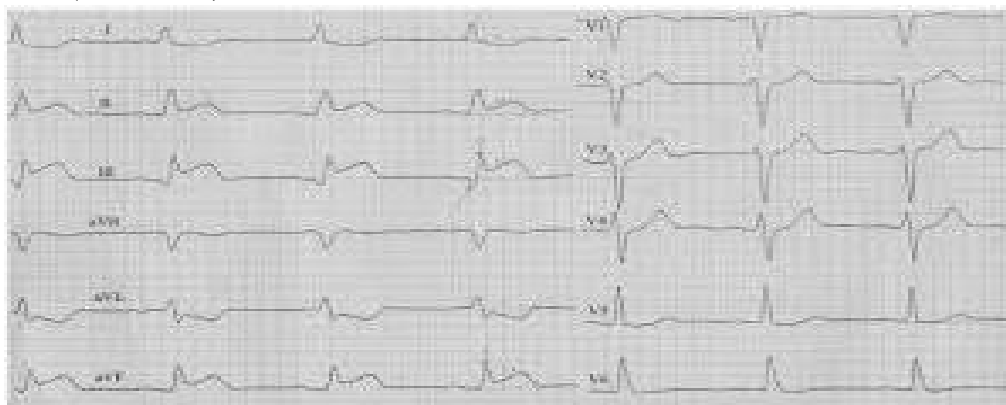
Скарги: інтенсивний біль за грудиною, запаморочення, загальна слабкість, відчуття нестачі повітря.

Анамнез хвороби: 30 хвилин назад після фізичного навантаження з'явився біль за грудиною. Після 3 таблеток нітрогліцерину біль не зменшився.

Об'єктивно: свідомість сплутана, шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт, дихання поверхневе часте, SpO₂ – 90%, Ps- 100 уд на хв., АТ-80/50 мм рт.ст.

Додатково

ЕКГ (додається)



Необхідно: інтерпретувати ЕКГ, встановити клінічний діагноз, визначити тактику надання невідкладної допомоги, надати невідкладну допомогу.

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		

2.1	Анамнез хвороби	Сказати «Що з Вами трапилось» Очікуваний відповідь «30 хвилин назад після фізичного навантаження з'явився біль за грудиною. Після 3 таблеток нітрогліцерину біль не зменшився.»
2.2	Скарги постраждалого	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «інтенсивний біль за грудиною, запаморочення, загальна слабкість, відчуття нестачі повітря.»
2.3	Анамнез життя	Сказати: «Які є супутні?» Очікувана відповідь: «Гіпертонічна хвороба»
2.4	Алергійний анамнез	Сказати «Чи були у Вас алергійні прояви раніше і на що?» Очікувана відповідь: «Ні»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Тяжкий: свідомість сплутана, шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт, дихання поверхневе часте, SpO2 -90%, Ps- 100 уд на хв., АТ-80/50 мм рт.ст. На ЕКГ- інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка STEMI
3.2	Прогресування хвороби	Сказати: «Під час проведення огляду постраждалий став млявим»
4. Діагностика		
4.1	Встановити клінічний діагноз	Сказати : Кардіогенний шок
5.Визначення тактики ведення та лікування. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
5.1	Перший крок: Для підвищення АТ перевага надається в/в або в/к крапельному введенню норепінефріну зі швидкістю 0,2-1 мкг/кг/хв під контролем ЧСС та АТ	Сказати: «Забезпечую венозний доступ і розпочинаю в/в ведення норепінефріну 8 мг (з розведенням ізотонічним розчином натрію хлориду (0,9% – 20 мл) мг зі швидкістю 0,2-1 мкг/кг/хв за допомогою інфузомату»
5.2	Другий крок: Всім пацієнтам з больовим синдромом застосовують морфін	Сказати: «Розпочинаю введення морфіну гідрохлориду: 10 мг (з розведенням ізотонічним розчином натрію хлориду (0,9% – 20 мл), дробно з 4-8 мг, наступні ін'єкції, – по2 мг кожні 5-15 хв. до зникнення болю

5.3	Третій крок: Всім пацієнтам з кардіогенним шоком при гіпоксії ($SpO_2 < 94\%$) вводити високу концентрацію кисню через маску до 6-8 літрів за хвилину. Маска повинна бути відповідного розміру. Її слід правильно	<i>Сказати:</i> «Щільно надягаю кисневу маску відповідного розміру на обличчя постраждалого та подаю потік 100% кисню 6–8 л/хв. Дати хворому навантажувальну дозу ацетилсаліцилової кислоти 300 мг per
-----	---	--

	та щільно надіти на обличчя пацієнта. Лікування ацетілсаліциловою кислотою	os»
5.4	Четвертий крок: застосування клопідогрелю. Пацієнти з кардіогенним шоком потребують постійного мониторінгу вітальних функцій та переведення до відділення інтенсивної терапії.	<i>Сказаати: «Дати хворому навантажувальну дозу клопідогрелю 600 мг per os</i> <i>Хворий бригадою екстреної невідкладної допомоги доставляється до профільного закладу для подальшого нагляду та лікування »</i>
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	<i>Сказати :-</i> Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень, виконання рекомендацій лікарів в подальшому обстежені та лікуванні.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати-</i> Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при дії алергенів на Ваш організм, і в подальшому при виникненні таких ситуацій не зволікати, а одразу викликати швидку.